

Pasuruan, 20 April 2026

Nomor : 245/RSPHS/I-UND/DIR/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi

Kepada Yth.

1. Seluruh Kepala Bidang Rumah Sakit
 2. Seluruh Kepala Ruang dan Kepala Instalasi
 3. Seluruh Ka.Komite dan PJ Tim Rumah Sakit
- di Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa akan diadakan **Rapat Koordinasi** di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada :

Hari / tanggal : Selasa / 21 April 2026
Pukul : 13.00 - selesai
Tempat : Hall Andalusia Lantai 3
Kegiatan : Rapat Koordinasi

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direktur RS Prima Husada,



Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M. Kep



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

LAPORAN EVALUASI PENGGUNAAN FASILITAS PENUNJANG

Tahun 2026

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

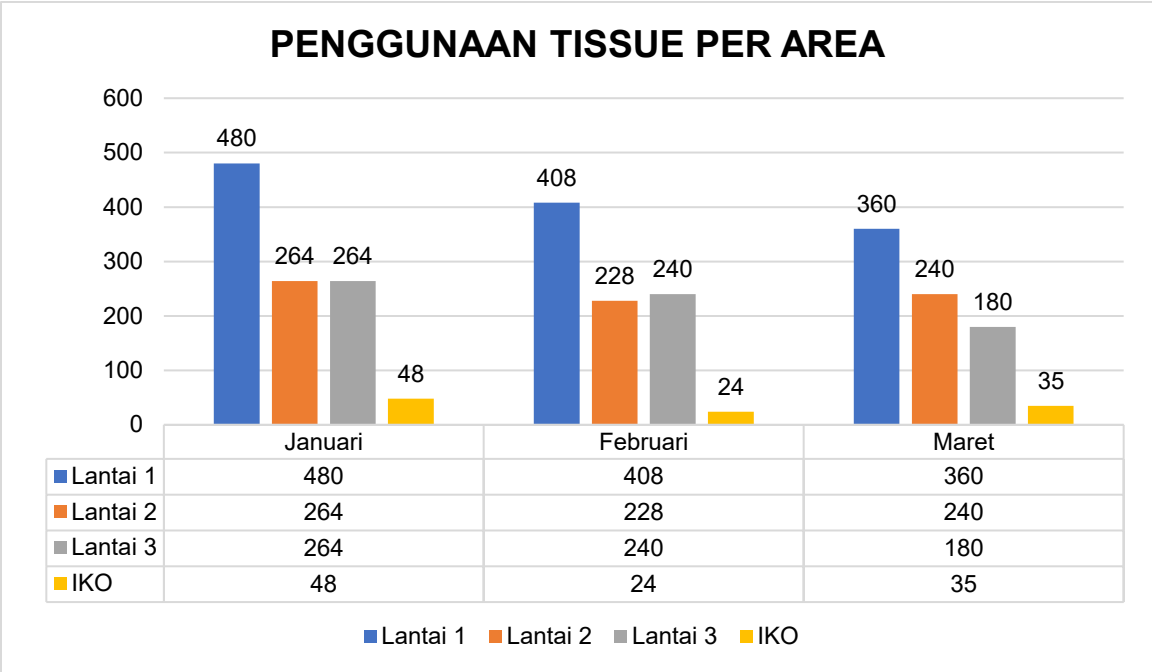
www.rs-primahusada.com

LAPORAN EVALUASI PENGGUNAAN TISSUE

Tabel 1.1 Penggunaan Tissue

No	Bulan	Penerimaan barang (Pack)	Area/Unit			
			Lantai 1	lantai 2	lantai 3	IKO
1	Januari	1056	480	264	264	48
2	Februari	900	408	228	240	24
3	Maret	815	360	240	180	35
4	April	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0
Total		2771	1248	732	684	107
Rata-rata per tahun		924	416	244	228	36
Rata-rata TW 1		924	416	244	228	36

Grafik 1.1 Penggunaan Tissue Per Area



Interpretasi :
Berdasarkan data penggunaan tisu pada periode Januari sampai dengan Maret 2026, terlihat bahwa jumlah penerimaan sekaligus penggunaan tisu mengalami tren penurunan secara bertahap setiap bulan. Pada bulan Januari tercatat penggunaan sebanyak 1056 pack, kemudian menurun pada bulan Februari menjadi 900 pack, dan kembali menurun pada bulan Maret menjadi 815 pack.

Tabel 1.2 PDSA Kebutuhan Tissue

Problem	Penggunaan tisu pada periode Januari–Maret 2026 masih tergolong cukup tinggi, terutama pada area dengan aktivitas pelayanan tinggi seperti Lantai 1. Meskipun terjadi tren penurunan penggunaan dari bulan Januari (1056 pack) ke Februari (900 pack) dan Maret (815 pack), namun belum terdapat standar baku penggunaan tisu per unit sehingga berpotensi menimbulkan penggunaan yang tidak efisien.
Step	Melakukan sosialisasi penggunaan tisu secara rasional kepada petugas <i>cleaning service</i> dan unit terkait, serta memperbaiki sistem monitoring dan pencatatan distribusi serta pemakaian tisu per area/unit setiap bulan.

Plan	1. Rencana Melaksanakan monitoring penggunaan tisu secara rutin setiap bulan pada masing-masing area/unit (Lantai 1, Lantai 2, Lantai 3, dan IKO), serta melakukan evaluasi kebutuhan logistik berdasarkan tingkat aktivitas pelayanan dan jumlah pasien. 2. Harapan Penggunaan tisu dapat terkendali secara efisien sesuai kebutuhan unit, terjadi penurunan penggunaan yang rasional tanpa mengganggu kebersihan lingkungan, serta tersedianya data penggunaan tisu yang akurat dan konsisten setiap bulan. 3. Analisa Terjadi penurunan penggunaan tisu dari Januari hingga Maret sebesar 241 pack ($\pm 23\%$). Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi penggunaan tisu dan pengendalian distribusi logistik. Namun demikian, penggunaan tertinggi masih berada pada Lantai 1 yang disebabkan oleh tingginya aktivitas pelayanan, frekuensi pembersihan, serta jumlah pasien dan pengunjung yang lebih banyak dibandingkan area lainnya. 4. Tindakan Menetapkan standar penggunaan tisu per unit berdasarkan kebutuhan pelayanan, meningkatkan pengawasan penggunaan tisu oleh koordinator <i>cleaning service</i>, serta memastikan ketersediaan stok tisu sesuai kebutuhan operasional dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan pengendalian logistik.
Do	1. Melakukan sosialisasi penggunaan tisu secara efisien kepada petugas <i>cleaning service</i> yang ditunjukkan kepada seluruh unit 2. Menetapkan distribusi tisu berdasarkan kebutuhan masing-masing area. 3. Melakukan pencatatan penggunaan tisu per unit setiap bulan. 4. Mengawasi penggunaan tisu oleh kepala ruangan / koordinator <i>cleaning service</i>. 5. Mengedukasi petugas untuk: a. Menggunakan tisu sesuai kebutuhan b. Menghindari penggunaan berlebihan c. Menggunakan alternatif membawa tissue untuk kepentingan pribadi
Study	1. Hasil monitoring terjadi tren penurunan penggunaan tissue selama 3 bulan. Pada bulan Januari ke Februari turun sebanyak 156 pack, bulan Februari ke Maret sebanyak 85 pack 2. Analisa penggunaan tissue menunjukkan adanya; a. Peningkatan efisiensi penggunaan b. Pengawasan yang lebih baik c. Distribusi yang lebih terkontrol d. Area dengan penggunaan tertinggi lantai 1 karena, 1) Aktivitas pelayanan tinggi 2) Jumlah kunjungan pasien banyak 3) Frekuensi cuci tangan tinggi
Action	1. Menetapkan standart penggunaan tisu per area/unit 2. Melakukan monitoring penggunaan tissue setiap bulan 3. Menetapkan buffer stok minimal

Lampiran :
PENDISTRIBUSIAN TISSU PER AREA

1. **LANTAI 1**

TOTAL KEBUTUHAN TISSU : 2,5 DUS

UNIT	TOTAL TISSU (DALAM PACK/MINGGU)
LAB	5
RAD	5
FARM	4
IGD	14
Masjid	5
IKO	6
TOTAL	59

2. **LANTAI 2**

TOTAL KEBUTUHAN TISSU : 2 DUS

UNIT	TOTAL TISSU (DALAM PACK/MINGGU)
HD	9
Mater	12
Neo	7
2A	10
2B	10
TOTAL	48

3. **LANTAI 3**

TOTAL KEBUTUHAN TISSU : 2 DUS

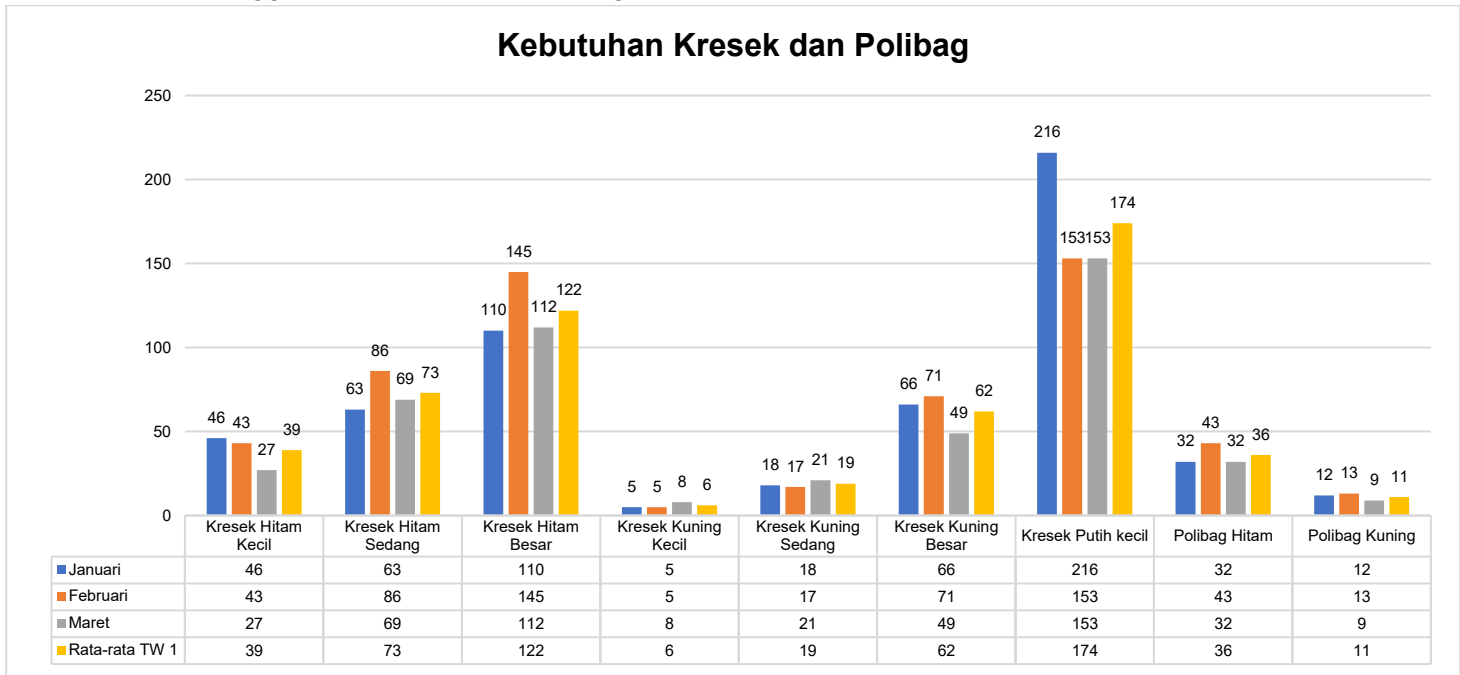
UNIT	TOTAL TISSU (DALAM PACK/MINGGU)
3A	10
3B	10
ICU	10
Sekretariat	3
HALL	Bila ada acara
TOTAL	33

LAPORAN EVALUASI PENGGUNAAN KRESEK

Tabel 2.1 Penggunaan Kresek dan Polibag

	Jenis Kresek kresek hitam besar (satuan pack)	Januari	Februari	Maret	Rata-rata TW 1
1	Kresek Hitam Kecil	46	43	27	39
2	Kresek Hitam Sedang	63	86	69	73
3	Kresek Hitam Besar	110	145	112	122
4	Kresek Kuning Kecil	5	5	8	6
5	Kresek Kuning Sedang	18	17	21	19
6	Kresek Kuning Besar	66	71	49	62
7	Kresek Putih kecil	216	153	153	174
8	Polibag Hitam	32	43	32	36
9	Polibag Kuning	12	13	9	11

Grafik 2.1 Penggunaan Kresek dan Polibag



Interpretasi :

Berdasarkan data penggunaan kresek dan polibag pada periode Januari sampai dengan Maret 2026, terlihat bahwa jumlah pemakaian kresek terbanyak pada penggunaan kresek putih kecil dengan rata-rata 174 pack untuk pelayanan farmasi, dan kresek hitam besar dengan rata-rata 122 pack untuk penggunaan sampah domestik di seluruh area rumah sakit.

Tabel 2.2

Problem	Penggunaan kresek dan polibag pada periode Januari sampai dengan Maret 2026 mengalami kenaikan dan penurunan sesuai dengan jumlah pasien serta kegunaan masing-masing jenis kresek dan polibag. Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut, - Peningkatan penggunaan kresek hitam besar pada bulan Februari (145 pack) - Penggunaan kresek putih kecil relatif tinggi dibanding jenis lainnya (rata-rata 174 pack) - Penggunaan kresek hitam kecil mengalami penurunan signifikan pada bulan Maret (27 pack) - Penggunaan polibag hitam dan kuning relatif stabil namun tetap perlu dikendalikan agar efisien
Step	Melakukan sosialisasi penggunaan kresek dan polibag sesuai dengan peruntukkan

Plan	1. Rencana Melaksanakan monitoring penggunaan kresek dan polibag secara rutin setiap bulan pada masing-masing unit pelayanan berdasarkan tingkat aktivitas pelayanan dan kebutuhan operasional. Monitoring dilakukan terhadap: a. Kresek hitam (kecil, sedang dan besar) b. Kresek kuning (kecil, sedang dan besar) c. Kresek putih d. Polibag hitam e. Polibag kuning Selain itu dilakukan evaluasi kebutuhan logistik berdasarkan, a. Jumlah pelayanna b. Aktivitas unit c. Kebutuhan pengelolaan limbah d. Penggunaan operasional harian 2. Harapan Penggunaan kresek dan polibag dapat terkendali secara efisien sesuai kebutuhan unit, tidak terjadi kelebihan distribusi logistik, serta mendukung pengendalian penggunaan plastik dalam kegiatan operasional rumah sakit. 3. Analisa Penggunaan kresek dan polibag pada periode Januari sampai dengan Maret 2026, terlihat bahwa jumlah pemakaian kresek terbanyak pada penggunaan kresek putih kecil dengan rata-rata 174 pack untuk pelayanan farmasi, dan kresek hitam besar dengan rata-rata 122 pack untuk penggunaan sampah domestik di seluruh area rumah sakit 4. Tindakan Menetapkan standar penggunaan kresek dan polibag sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit penunjang, umum dan pelayanan
Do	Melaksanakan pencatatan dan monitoring penggunaan kresek dan polibag selama periode Januari sampai Maret pada seluruh unit pelayanan. Berdasarkan hasil monitoring: 1. Penggunaan kresek hitam besar mengalami peningkatan pada bulan Februari 2. Penggunaan kresek hitam sedang relatif stabil dengan rata-rata penggunaan tertinggi dibanding ukuran hitam lainnya 3. Penggunaan kresek hitam kecil menurun pada bulan Maret 4. Penggunaan kresek kuning kecil, sedang, dan besar relatif stabil 5. Penggunaan polibag hitam dan kuning masih dalam batas kebutuhan operasional Monitoring dilakukan melalui rekapitulasi pemakaian logistik setiap bulan.
Study	1. Berdasarkan hasil evaluasi penggunaan periode Januari–Maret diperoleh bahwa: a. Terdapat fluktuasi penggunaan pada beberapa jenis kresek hitam terutama ukuran besar b. Penggunaan kresek kuning relatif stabil karena digunakan sesuai kebutuhan pemilahan limbah c. Penggunaan polibag masih terkendali sesuai kebutuhan unit pelayanan d. Secara umum penggunaan kresek dan polibag masih dalam batas wajar dan sesuai kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit 2. Analisa penggunaan kresek dan polibag a. Peningkatan penggunaan kresek hitam besar pada bulan Februari (145 pack) untuk tempat sampah domestik b. Penggunaan kresek putih kecil relatif tinggi dibanding jenis lainnya (rata-rata 174 pack) untuk kegiatan farmasi c. Penggunaan kresek hitam kecil mengalami penurunan signifikan pada bulan Maret (27 pack)

	d. Penggunaan polibag hitam dan kuning relatif stabil namun tetap perlu dikendalikan agar efisien e. Masih adanya temuan dari unit melakukan penginputan kresek di Gudang umum
Action	1. Melanjutkan monitoring penggunaan kresek dan polibag setiap bulan 2. Melakukan evaluasi kebutuhan distribusi logistik pada unit dengan penggunaan tinggi 3. Mengoptimalkan penggunaan kresek sesuai fungsi pemilahan limbah 4. Meningkatkan koordinasi dengan unit pelayanan terkait permintaan logistik 5. Melakukan evaluasi kembali pada Triwulan II sebagai bahan perbaikan perencanaan distribusi logistik berikutnya

Lampiran

1. Kegunaan Kresek dan Polibag

No	Nama barang	Unit	Kegunaan
1	Kresek putih kecil	Farmasi	Distibusi obat ke pasien
		Laboratorium	untuk sampel rujukan
2	Kresek putih sedang	-	-
3	Kresek hitam kecil	<i>Cleaning service</i>	untuk muntahan pasien barang pasien tertinggal di IRNA
		Farmasi	Distibusi obat ke pasien
4	Kresek hitam sedang	<i>Cleaning service</i>	untuk tempat sampah domestik ukuran 30lt
		CSSD	untuk tempat sampah domestik ukuran 30lt
5	Kresek hitam besar	<i>Cleaning service</i>	untuk tempat sampah domestik ukuran 50lt
		CSSD	distribusi kasa ke farmasi
		Laundry	linen rusak
		Dapur	untuk tempat sampah domestik dapur di pantry
6	Kresek kuning besar	<i>Cleaning service</i>	untuk tempat infeksius ukuran 50lt
		CSSD	linen kotor diruang dekontaminasi alat
7	Kresek kuning sedang	<i>Cleaning service</i>	tempat sampah infeksius ukuran 15lt
		Laboratorium	untuk linen gown petugas
		CSSD	tempat sampah infeksius ukuran 15lt
8	Kresek kuning kecil	Maternitas	untuk tempat plasenta
		CSSD	untuk tempat gumpalan jaringan
9	Polibag hitam	<i>Cleaning service</i>	untuk tempat sampah domestik jika kresek hitam besar habis tempat sampah di depo farmasi tempat pengantaran gorden kotor ke laundry
		Dapur	untuk tempat sampah domestik dapur di pantry (sulo)
10	Polibag kuning	<i>Cleaning service</i>	Tempat sampah infeksius IKO, IPAL

Lampiran

2. Distribusi kresek CS per unit

No	Bulan	Penerimaan barang Kresek hitam besar (Pack isi 20 pcs)	Area/Unit				
			Lantai 1	lantai 2	lantai 3	Taman	IKO
1	Januari 26	69	14	19	20	7	9
2	Februari 26	72	19	20	20	5	8
3	Maret 26	83	18	21	28	7	9
4	Apr-26						
5	Mei 26						
6	Juni 26						
7	Juli 26						
8	Agustuts 26						
9	Sep-26						
10	Oktober 26						
11	Nov-26						
12	Desember 26						
Total		224	51	60	68	0	26

No	Bulan	Penerimaan barang polibag hitam (Pack isi 50 pcs)	Area/Unit				
			Lantai 1	lantai 2	lantai 3	Taman	IKO
1	Januari 26	1250	500	300	250	200	0
2	Februari 26	1450	500	350	350	250	0
3	Maret 26	1500	500	350	350	300	0
4	Apr-26						
5	Mei 26						
6	Juni 26						
7	Juli 26						
8	Agustuts 26						
9	Sep-26						
10	Oktober 26						
11	Nov-26						
12	Desember 26						
Total		4200	1500	1000	950	0	0

No	Bulan	Penerimaan barang Kresek hitam sedang (Pack isi 50 pcs)	Area/Unit				
			Lantai 1	lantai 2	lantai 3	Taman	IKO
1	Januari 26	2550	600	800	700	0	450
2	Februari 26	3100	750	900	850	0	600
3	Maret 26	3550	850	1000	950	0	750
4	Apr-26						
5	Mei 26						
6	Juni 26						
7	Juli 26						
8	Agustuts 26						
9	Sep-26						
10	Oktober 26						
11	Nov-26						
12	Desember 26						
Total		9200	2200	2700	2500	0	1800

No	Bulan	Penerimaan barang Kresek Kuning besar (Pack isi 20 pcs)	Area/Unit				
			Lantai 1	lantai 2	lantai 3	Taman	IKO
1	Januari 26	1180	380	400	400	0	0
2	Februari 26	1100	300	400	400	0	0
3	Maret 26	1360	380	490	490	0	0
4	Apr-26						
5	Mei 26						
6	Juni 26						
7	Juli 26						
8	Agustuts 26						
9	Sep-26						
10	Oktober 26						
11	Nov-26						
12	Desember 26						
Total		3640	1060	1290	1290	0	0

No	Bulan	Penerimaan barang Kresek Kuning sedang (Pack isi 50 pcs)	Area/Unit				
			Lantai 1	lantai 2	lantai 3	Taman	IKO
1	Januari 26	3	3	0	0	0	0
2	Februari 26	4	3	1	0	0	0
3	Maret 26	4	3	0	1	0	0
4	Apr-26						
5	Mei 26						
6	Juni 26						
7	Juli 26						
8	Agustuts 26						
9	Sep-26						
10	Oktober 26						
11	Nov-26						
12	Desember 26						
Total		11	9	1	1		0

No	Bulan	Penerimaan barang Polibag kuning (Pack isi 50 pcs)	Area/Unit				
			Lantai 1	lantai 2	lantai 3	Taman	IKO
1	Januari 26	0	0	0	0	0	0
2	Februari 26	450	0	0	0	0	450
3	Maret 26	550	0	0	0	0	550
4	Apr-26						
5	Mei 26						
6	Juni 26						
7	Juli 26						
8	Agustuts 26						
9	Sep-26						
10	Oktober 26						
11	Nov-26						
12	Desember 26						
Total		1000	0	0	0	0	1000



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
SUKOREJO

KOMITE PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien)

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa LemahbangKec. Sukorejo – Pasuruan
Telp : 0343 – 6745000 | Email : info.sukorejo@rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com



Tujuan

- Evaluasi capaian indikator nasional mutu dan keselamatan pasien
- Identifikasi permasalahan dan kendala di lapangan

Indikator Nasional Mutu



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
SUKOREJO

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan



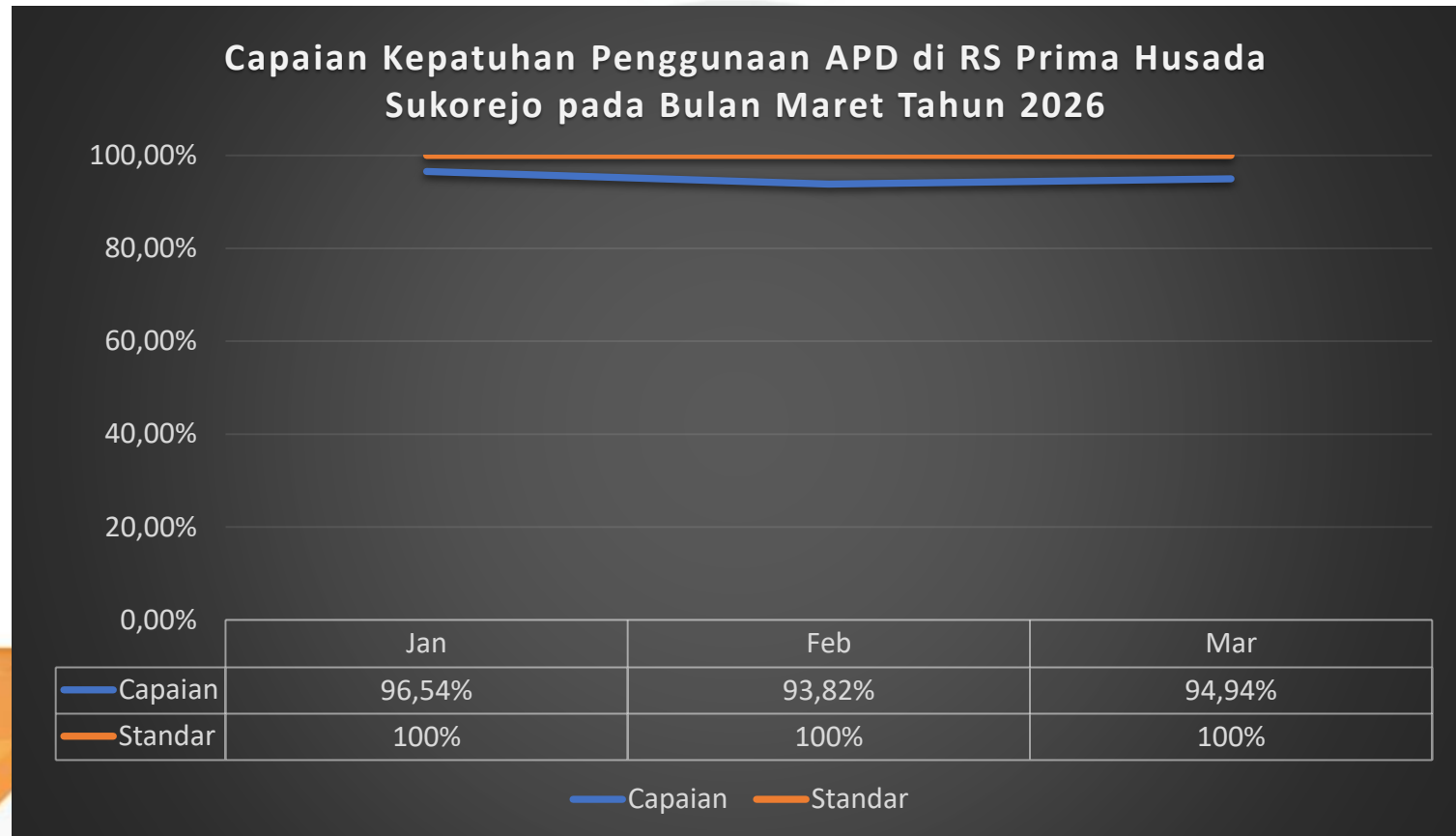
- Kebersihan tangan naik setiap bulan
- Mencapai standar 85%

Indikator Nasional Mutu



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
SUKOREJO

2. Kepatuhan Penggunaan APD

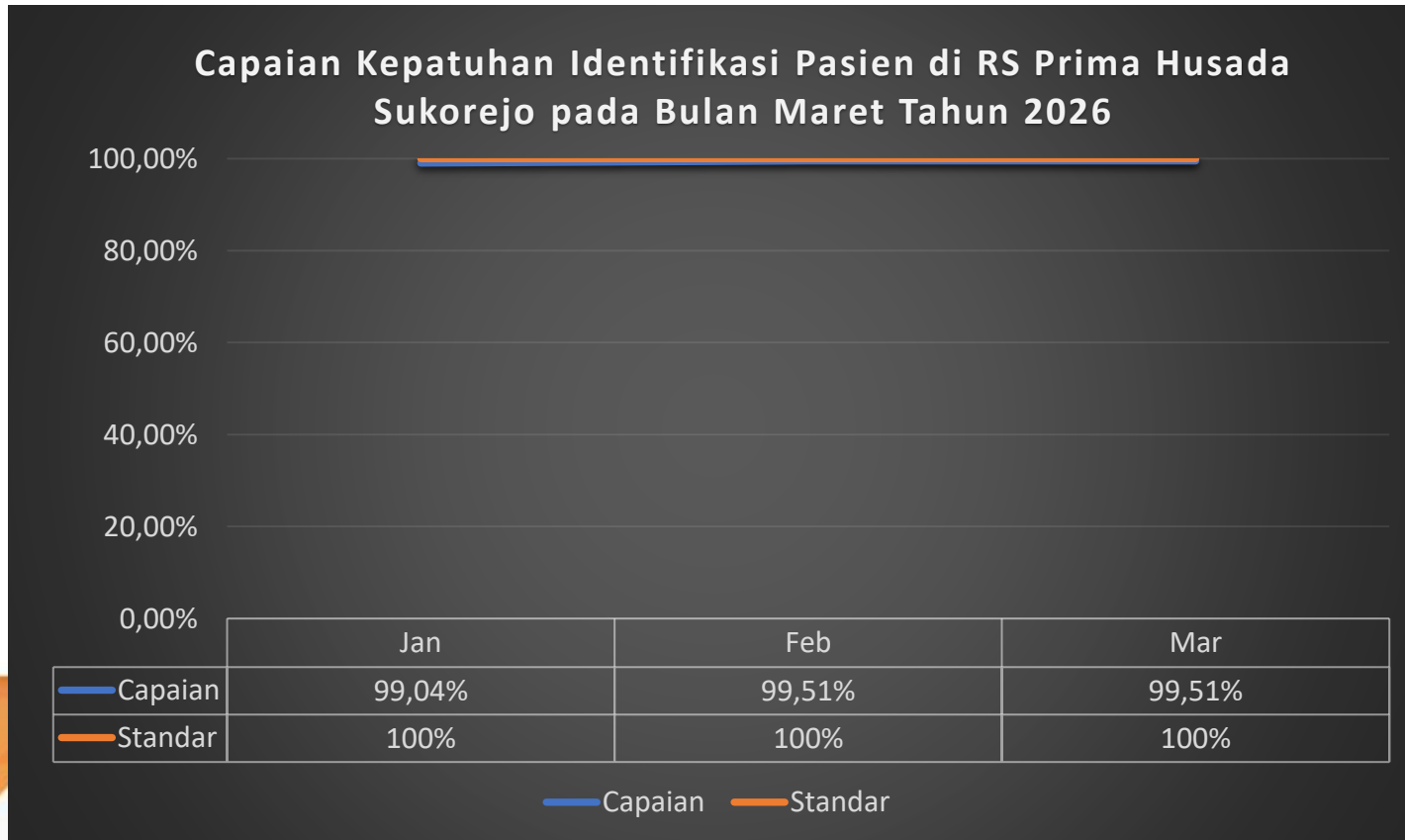


- Kepatuhan penggunaan APD naik setiap bulan
- Belum mencapai standar 100%

2. Kepatuhan Penggunaan APD pada bulan Maret

- Capaian **94,94%** → **Belum mencapai standar (100%)**
- Gap **5,06%** masih berisiko terhadap **infeksi pada petugas & pasien**
- Ketidakpatuhan dipengaruhi oleh:
 - Kejenuhan penggunaan APD
 - Persepsi risiko menurun
 - Pengawasan belum konsisten

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien



- Kepatuhan identifikasi pasien belum memenuhi standar 100%

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien

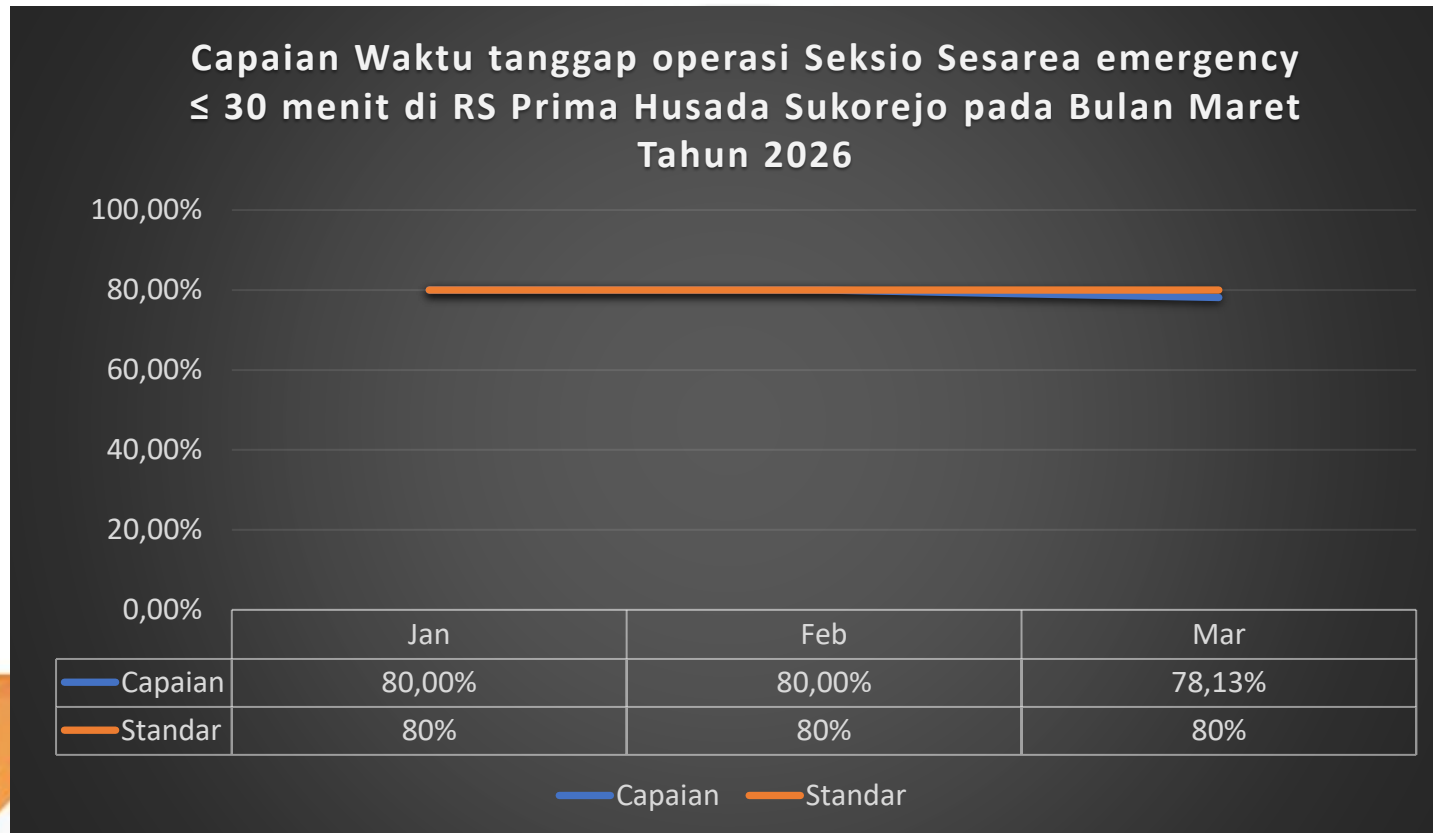
- Capaian **99,51%** → **Belum memenuhi standar (100%)**
- Masih ada **30 ketidakpatuhan** dari **6.097 observasi (0,49%)**
- Ditemukan **tidak dilakukan verifikasi gelang** pada tindakan krusial (injeksi, sampling darah, transfusi, dll)
- Terjadi gap: **“bertanya nama” ≠ “verifikasi gelang sesuai standar”**

Indikator Nasional Mutu



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
SUKOREJO

4. Waktu tunggu SC Emergency ≤ 30 Menit

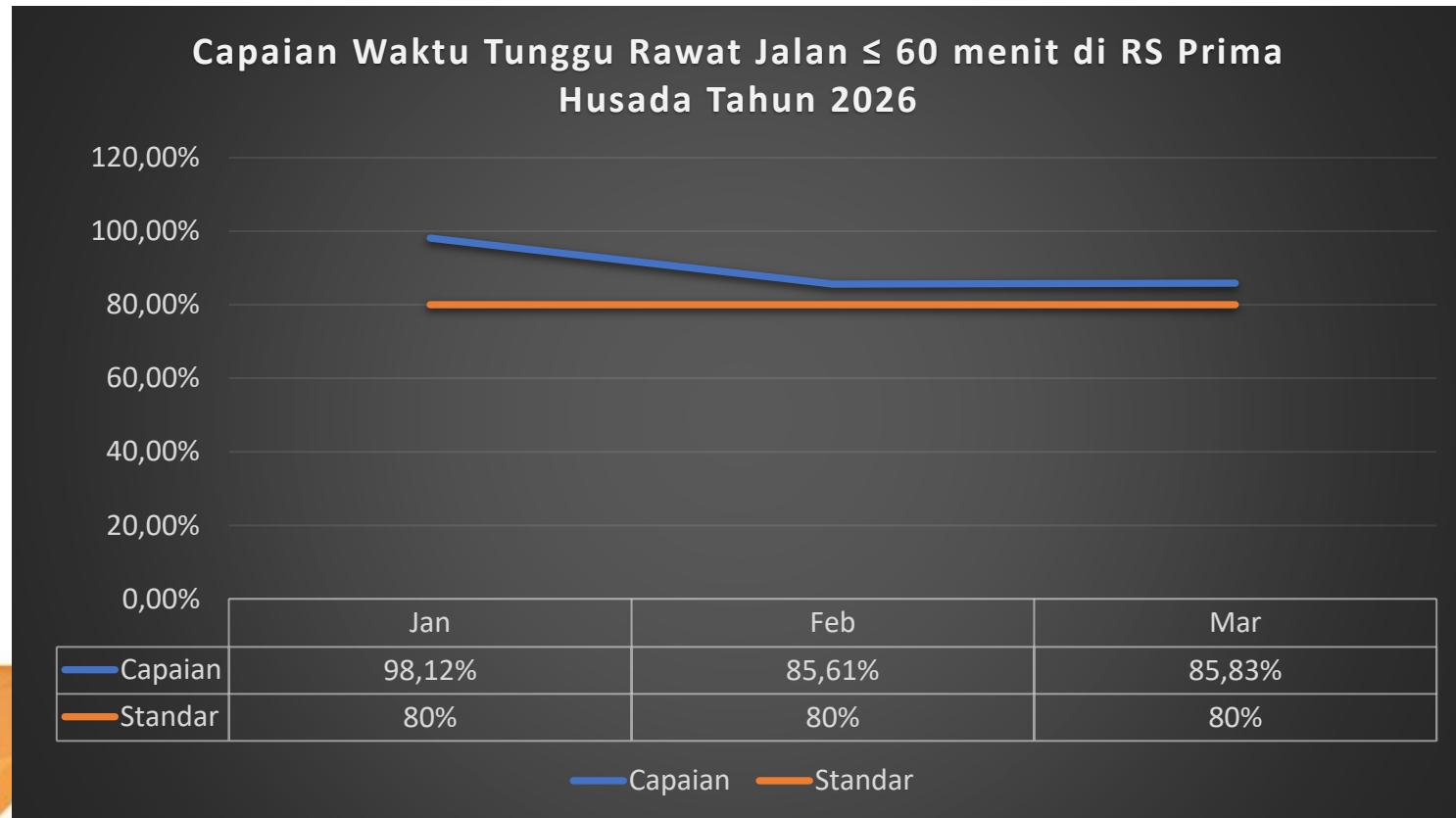


- Capaian waktu tunggu SC Emergency turun pada bulan Maret, sehingga belum mencapai standar 80%

4. Waktu tunggu SC Emergency ≤ 30 Menit

- Capaian **78,13%** → **Belum memenuhi standar ($\geq 80\%$)**
- Gap **1,87%** berisiko pada **keselamatan ibu & bayi**
- Keterlambatan utama disebabkan:
 - **DPJP tidak berada di RS saat emergency**
 - **Waktu tempuh > 30 menit**
- Target sulit tercapai tanpa **kesiapan dokter on-site**

5. Waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 Menit



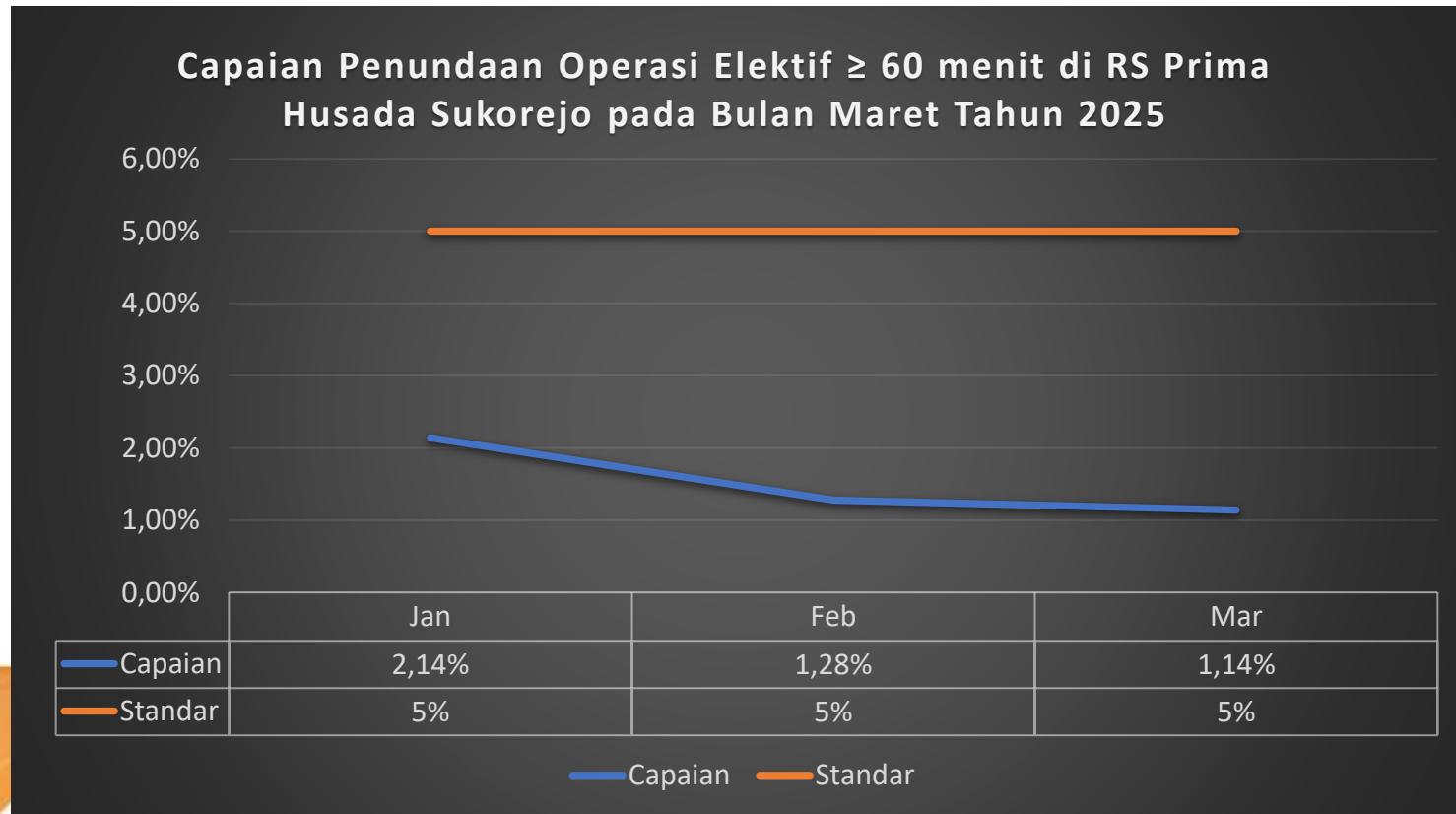
- Capaian waktu tunggu rawat jalan mencapai standar, namun mengalami penurunan dibandingkan Januari

Indikator Nasional Mutu



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
SUKOREJO

6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 Menit



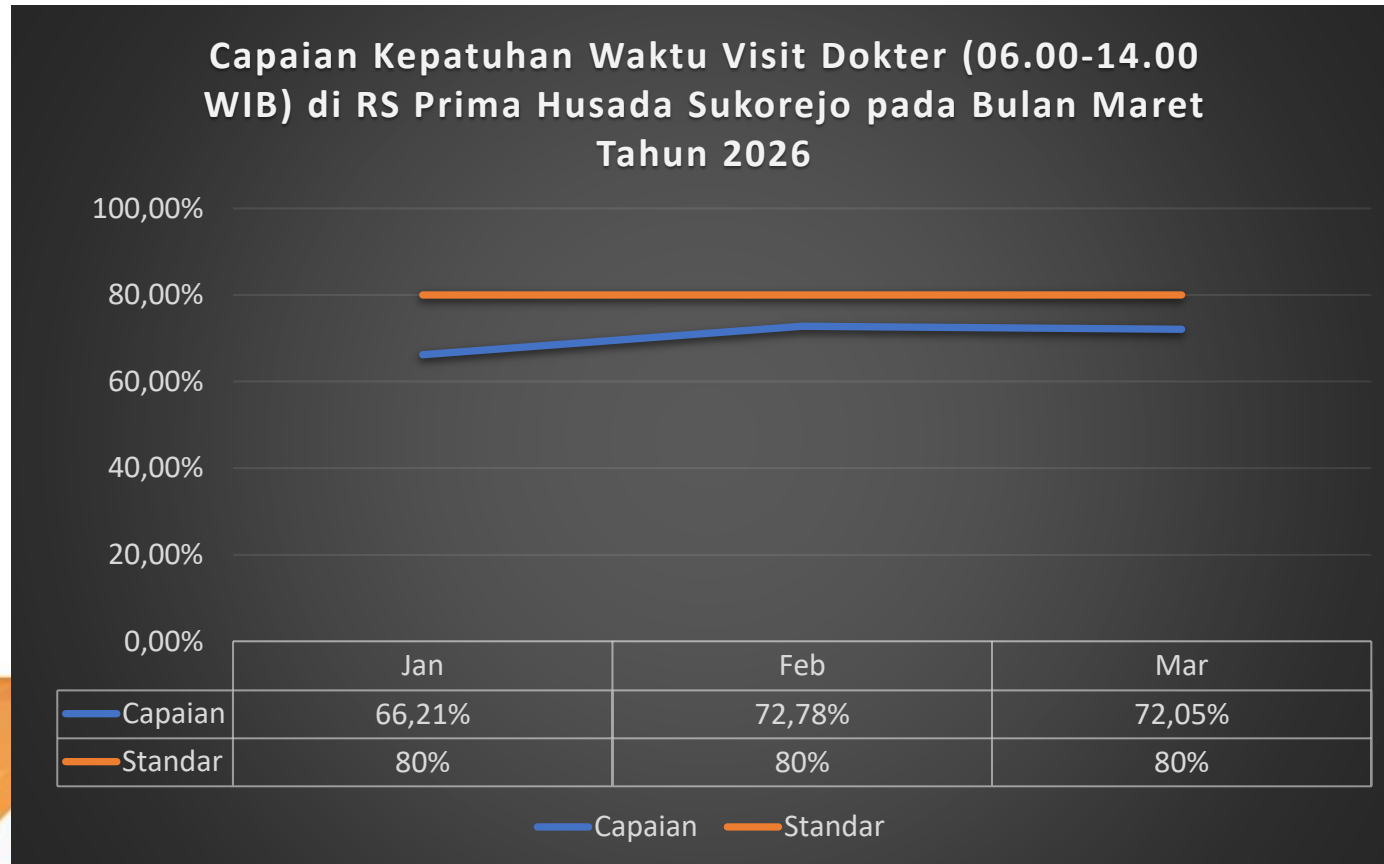
- Penundaan operasi elektif mencapai standar $< 5\%$ dalam tiga bulan terakhir

Indikator Nasional Mutu



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
SUKOREJO

7. Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis $\leq$ jam 14.00 WIB

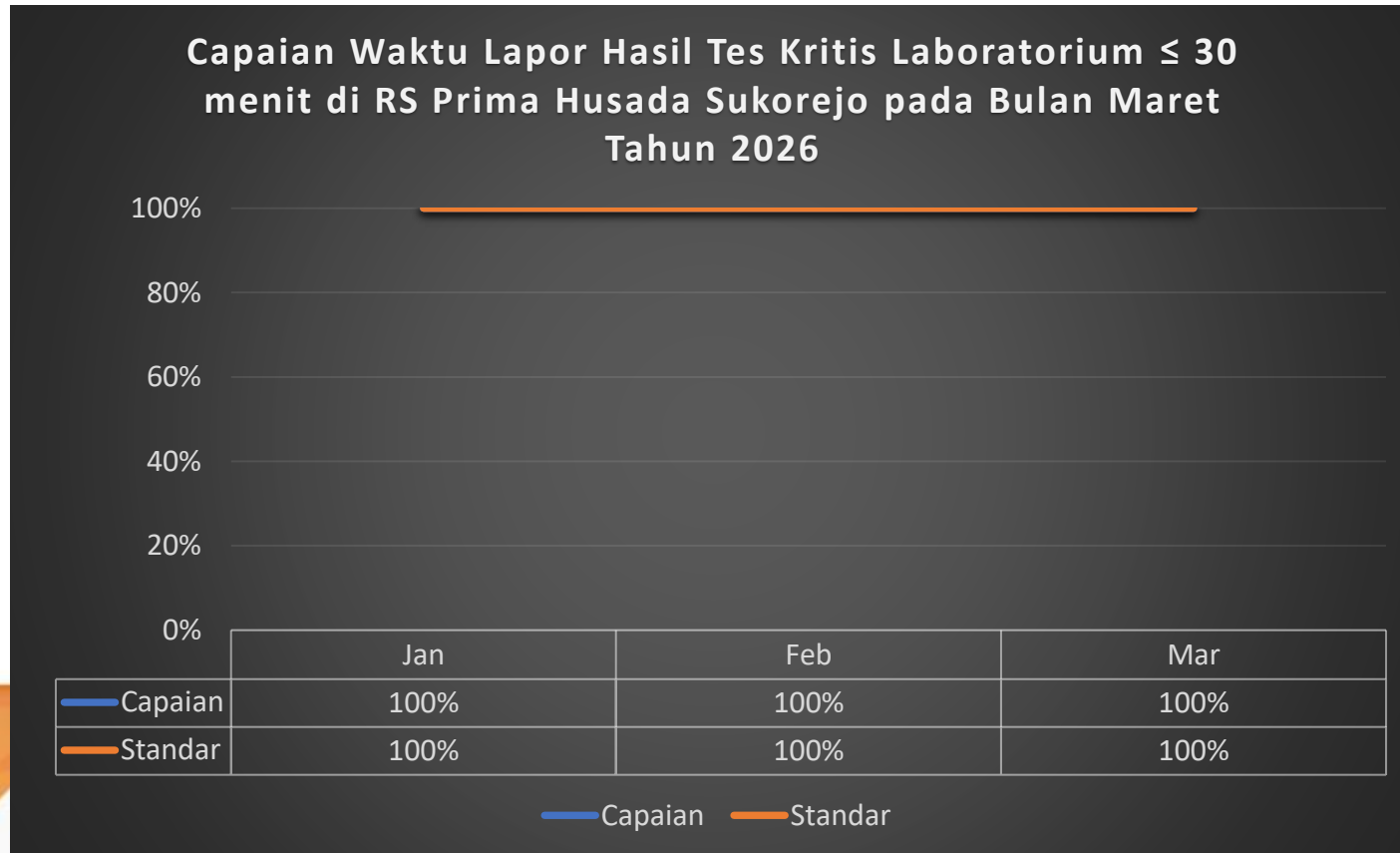


- Kepatuhan jam visite dokter belum mencapai standar 80% dalam tiga bulan terakhir

7. Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis $\leq$ jam 14.00 WIB

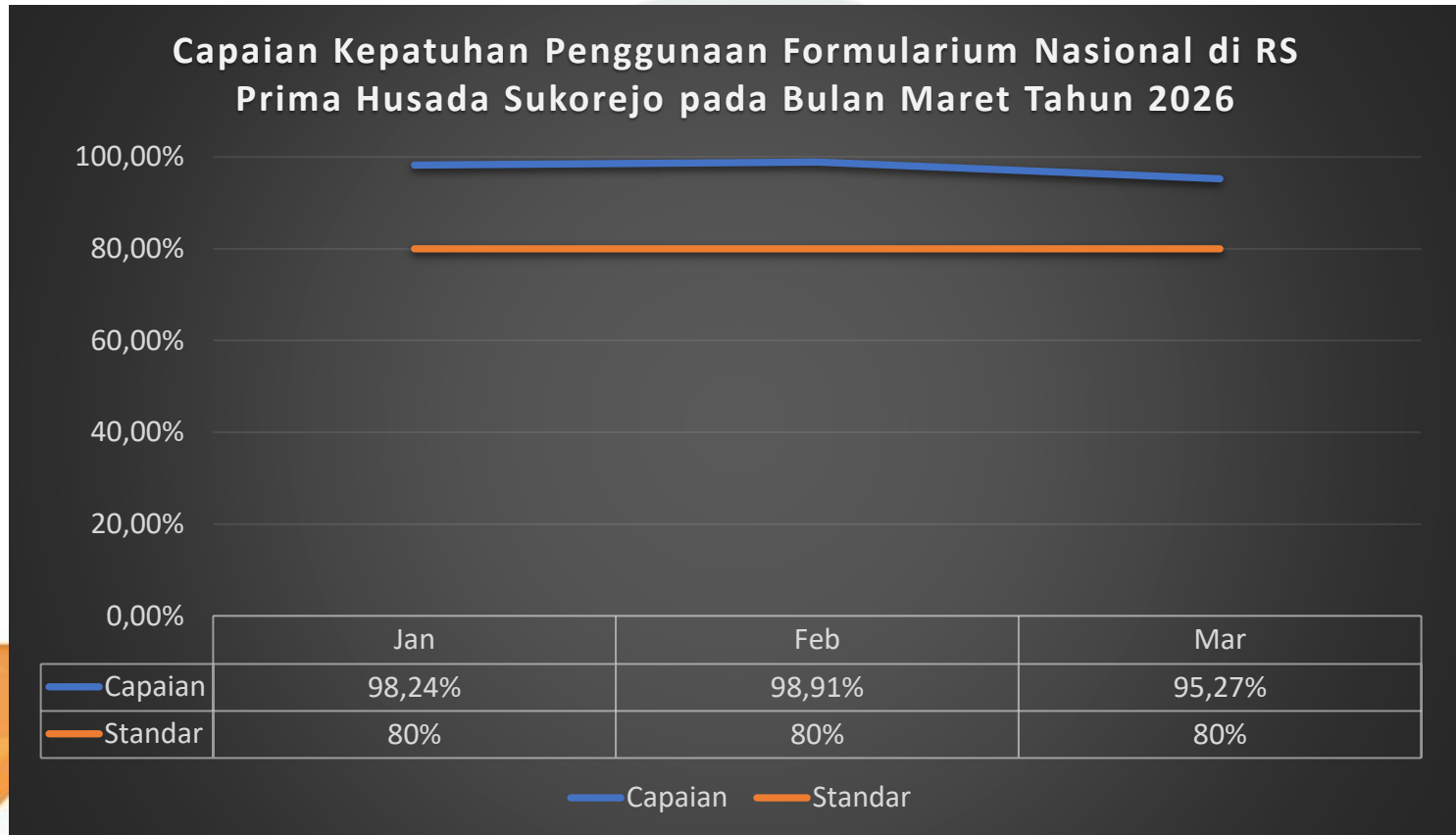
- Capaian **72,05%** → **Belum memenuhi standar ($\geq 80\%$)**
- **225 pasien (dari 805) divisite > 14.00 WIB**
- Dampak:
 - **Penundaan terapi & pemeriksaan**
 - **Keterlambatan pemulangan pasien**
- Akar masalah utama:
 - **Bentrok jadwal praktik dokter di RS lain**
 - **Belum tersedia dokter ruangan**

8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 60 menit



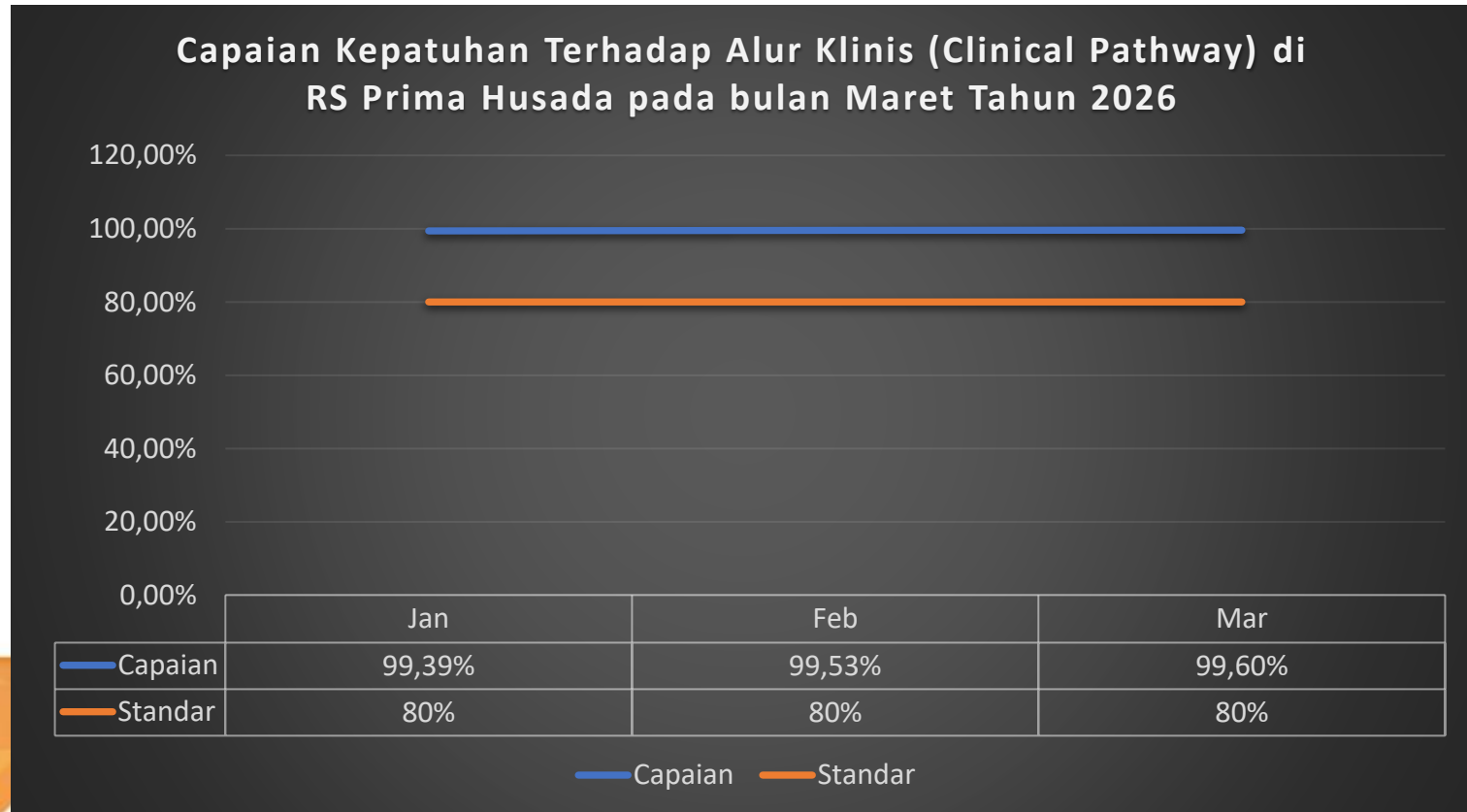
- Telah memenuhi standar 100%

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



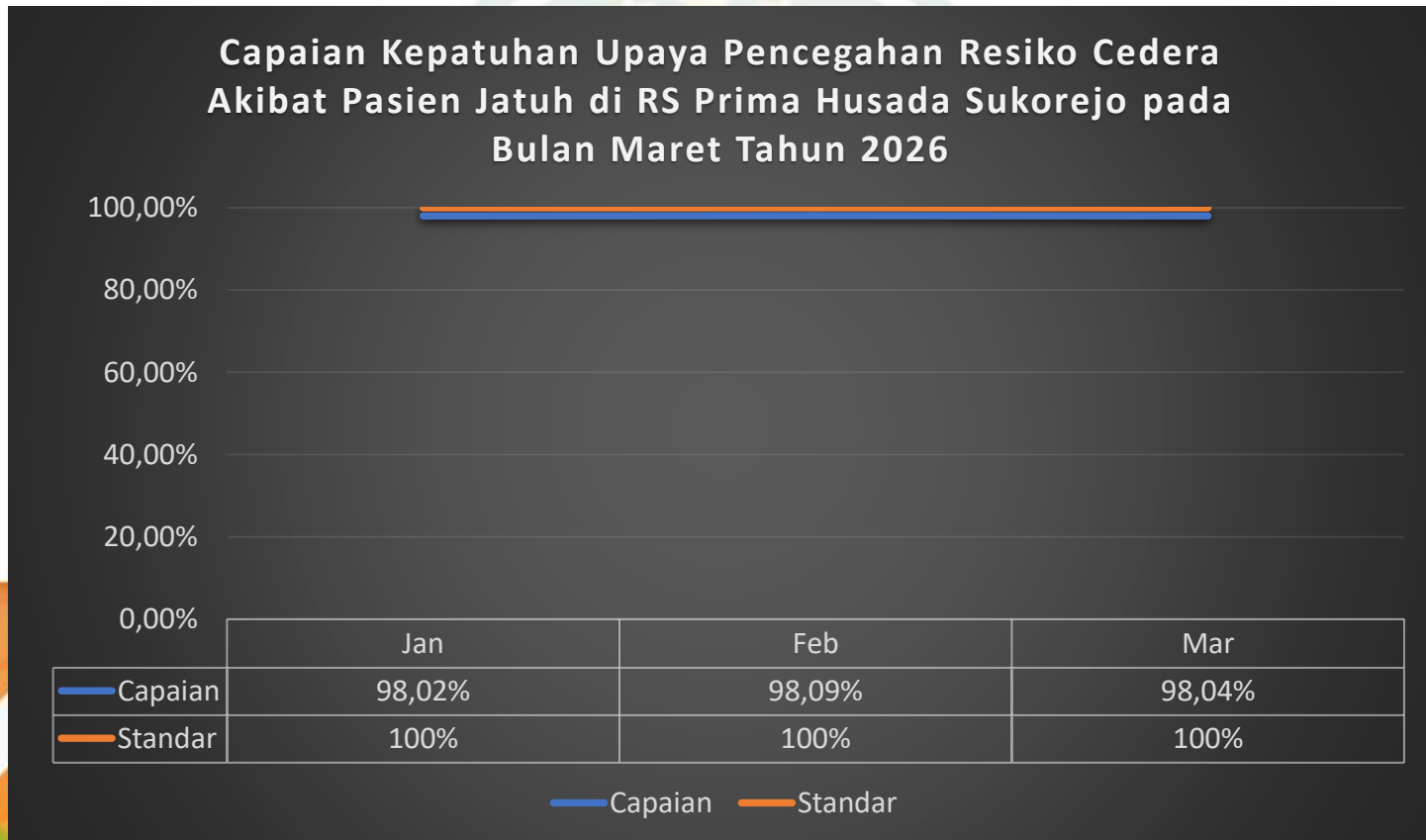
- Telah memenuhi standar 80%

10. Kepatuhan terhadap Alur Klinis



- Telah memenuhi standar 80%

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh

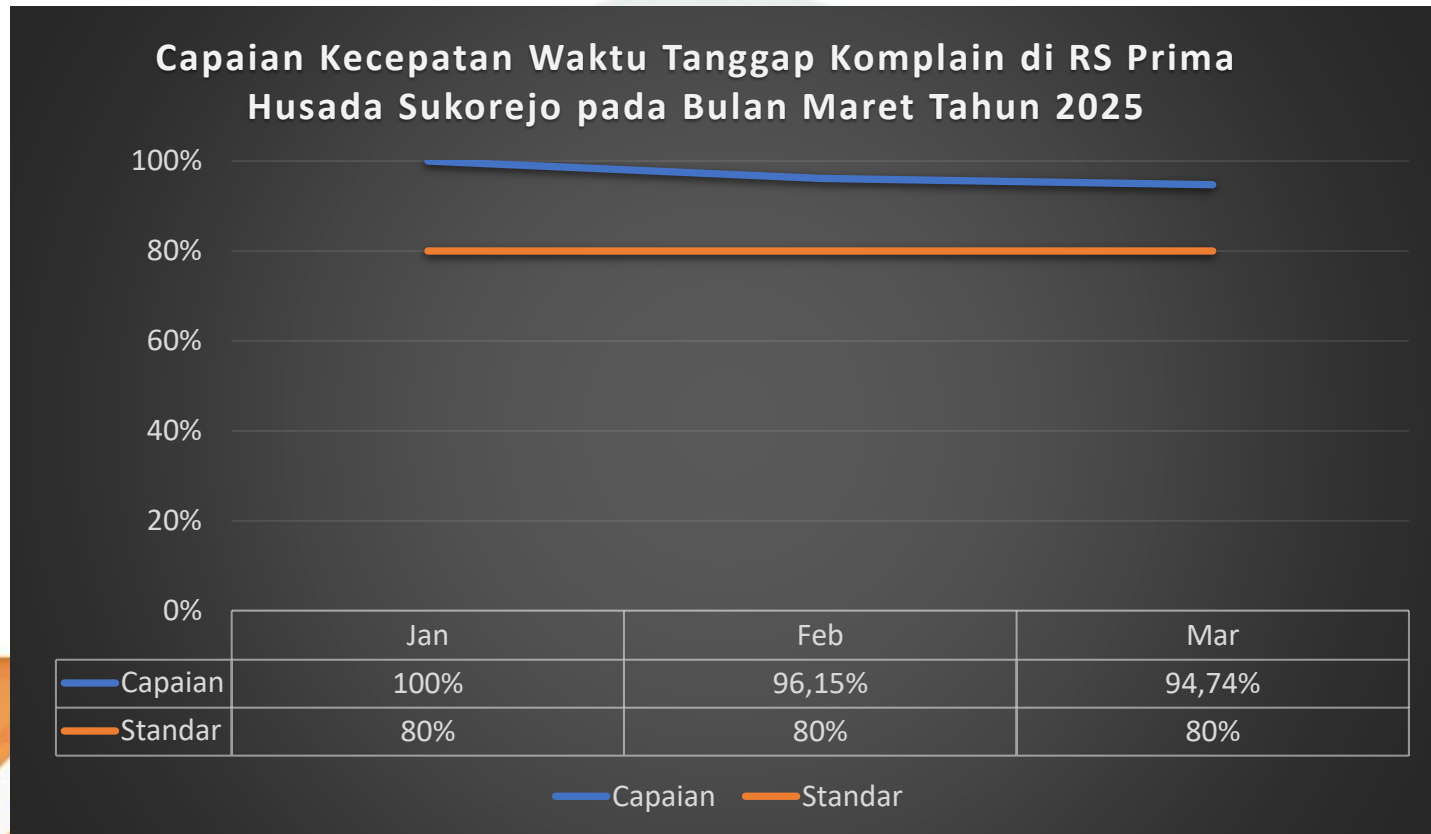


- Belum memenuhi standar 100%

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh

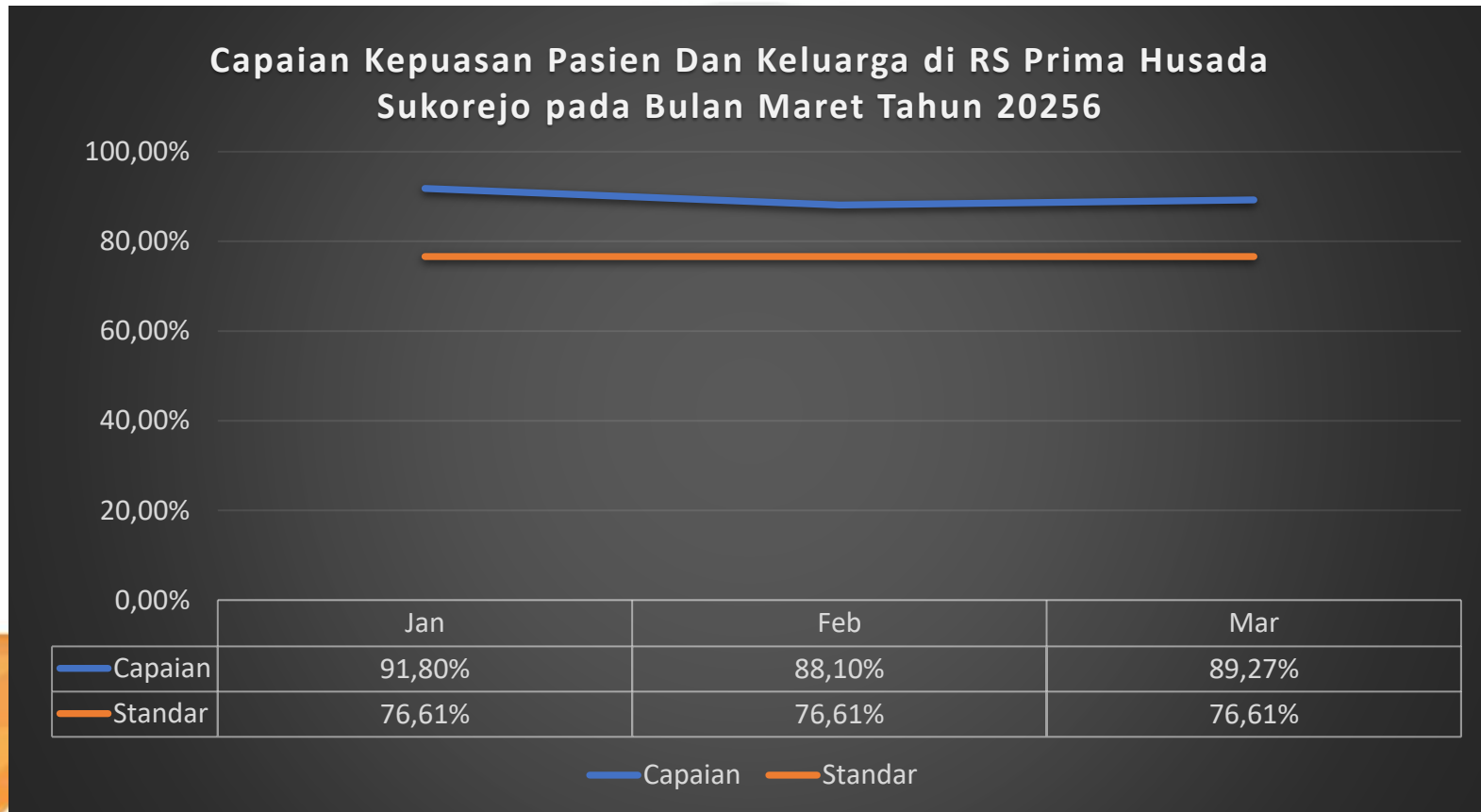
- Capaian **98,04%** → **Belum memenuhi standar (100%)**
- **24 pasien (1,96%)** belum mendapat perlindungan sesuai standar
- Temuan kritis:
 - **Tidak ada tanda risiko jatuh di bed**
 - **Handrail tidak terpasang/terkunci**
 - **Edukasi pasien/keluarga belum optimal**
 - **Identifikasi gelang risiko jatuh tidak dilakukan**

12. Kepatuhan Waktu Tanggap Komplain



- Telah memenuhi standar 80%, namun mengalami penurunan dibandingkan Januari

13. Kepuasan Pasien



- Telah memenuhi standar 76,61% dalam tiga bulan terakhir

Insiden Keselamatan Pasien



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
SUKOREJO

Jenis Insiden /Bulan	Januari	Februari	Maret	TOTAL
KPC	9	8	2	19
KNC	1	1	3	5
KTC	-	2	3	5
KTD	4	3	2	9
Sentinel	-	4	-	4
TOTAL	14	18	10	42

Insiden Keselamatan Pasien



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
SUKOREJO

- Pelaporan insiden maksimal 2x24 jam namun keadaan di lapangan masih belum sesuai standar

659	03-Mar-26	03-Mar-26
660	08-Mar-26	08-Mar-26
661	16-Mar-26	18-Mar-26
662	06-Mar-26	23-Mar-26
663	18-Mar-26	23-Mar-26
664	14-Mar-26	23-Mar-26
665	23-Mar-26	31-Mar-26
666	17-Mar-26	03-Apr-26
667	03-Mar-26	03-Apr-26
668	17-Mar-26	07-Apr-26

Maret

KNC	Laboratorium	Laboratorium
KPC	Laboratorium	IRNA 2A
KTD	Komite PFI	Pasien
KTC	IRJA	IRNA 3B
KPC	IGD	IRNA 3A
KTC	IGD	IGD & IRNA 3B
KTD	Kabid Penunjang	Radiologi
KNC	Farmasi	IRNA 2A
KNC	IRNA 2A	Farmasi
KTC	IRNA 2A	IRNA 2A

Tanggal terjadi insiden

Tanggal pelaporan

NOTULEN

HARI / TANGGAL :
PUKUL : 13.00 - SELESAI
AGENDA RAPAT : RAPAT KOORDINASI

PEMIMPIN RAPAT : Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep
NOTULIS : Arindha Rahma
TEMPAT : Hall Andalusia

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Tindak Lanjut Rakor Maret	1. Efisiensi : (1) PPI re design penggunaan APD di ruangan, (2) evaluasi kebutuhan kresek dan tisu di ruangan apakah sudah? 2. Penurunan Kunjungan Pasien Perusahaan : humas melakukan Analisa kenapa ada penurunan 3. Monev Penurunan pasien ranap, angka complain apakah masih tinggi? 4. Rattng Kessan dan Google Review masih kurang, unit apakah sudah menerapkan utnuk pengisian review 5. Gizi : Roaster yang baru apakah masih ada kendala? 6. IRNA 3A : ada kendala penyelesaian obat pulang, apakah masih ada kendala? 7. Farmasi : (1) anak baru apakah sudah memahami keseluruhan alur dan spo di farmasi? (2) perapihan spreadsheet untuk penyerahan obat kronis rawat jalan apaakh	1. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah dijalankan sesuai aturan terbaru 2. Perbaiki keluhan perusahaan terkait slow repson dari pihak rs, lakukan kajian ulang ke semua perusahaan 3. Perbaiki angka complain dengan program PE 4. Tingkatkan edukasi pengisian google review 5. Staf sudah dapat menggunakan alat 6. Sudah tidak ada kendala 7. Sudah berjalan	PPI Humas All staf All staf pelayanan Gizi,jangmed Farmasi

		sudah dilakukan? Apakah masih ada kendala dalam pencarian data? 8. Laboratorium : pengajuan ke programmer terkait kelengkapan blangko print apakah sudah? Apakah sudah dibuatkan SPO? 9. Security : apakah pengadaan kartu sesuai jumlah TT sudah berjalan? Apakah SPO sudah ada? 10. CSSD : apakah identifikasi untuk pengajuan box dengan unit yg memiliki instrument besar sudah di data? 11. Rekam Medis : (1) Penataan DRM sampai mana progressnya? (2) form tranfusi lab apakah sudah masuk ke system?	8. Sudah berjalan 9. Belum berjalan, katrena ada perubahan percetak redesign kartu 10. Sudah dikorodinasikan dan proses pengajuan 11. Sudah berjalan dan Form tranfusi lab proses dipenuhi	Laboratorium Kabid umum keu Cssd Rekam medis, jangmed
2.	PPI	1. Beberapa unit masih ada yang belum menerapkan hh dengan baik 2. Pemilahan sampah infeksius dan non infeksius masih kurang, masih ditemukan sampah tercampur 3. Polybag dilakukan pengusulan yang lebih besar 4. Efisiensi kresek dan tisu diterapkan 5. kejadian phlebitis masih tinggi (terutama di IRNA 2B) , bberapa unit belum melaporkan secara maksimal 6. penemuan IDO setiap bulan masih ada satu setiap bulannya	1. PIC PPI unit wajib mengedukasi seluruh staf di unitnya terkait HH 2. Diperbaiki kembali pemilahan sampah infeksius dan non infeksius hal ini juga akan berpengaruh terhadap efisiensi kresek 3. Proses pengajuan ke direktur 4. Unit mematuhi kebijakan yang berlaku 5. evaluasi Kembali terkait pelaporan dan kejadian knapa masih tinggi 6. lakukan evaluasi kejadian	PIC PPI all unit PPI All staf All karu yanmed PPI

3.	SDM	pengajuan cuti dan penggabungan libur	staf terkait wajib menghadap ke kabid dan SDM untuk hafalan mutu, visi misi, IMP Unit, IMP RS, HH, >> buat edaran	All unit dan sekre
4.	PONEK	1. Adanya pergantian ketua tim ponek sekarang dengan dr agung 2. Jejaring rujukan sudah berjalan di tahun ini	1. Sampaikan dan jalankan ponek 2. Umandok kegiatan wajib terdokumentasikan dengan baik	Tim ponek
5.	Komite Keperawatan	KOMKEP belum berjalan maksimal (mutu, kreden, etik)	segera dijalankan tahun ini	All anggota komkep
6.	Komite medik	1. Angka keterlambatan DPJP masih tinggi 2. DPJP melakukan PRB tanpa melakukan iter 2x sesuai surat edaran yang telah diterapkan, sehingga angka capaian iter tidak tercapai 3. Adanya penurunan rehab medik, karena kebijakan BPJS terbaru, dr Eko masih mempermasalahkan alur yang berjalan	1. DPJP yang sering terlambat direview kembali jam hfisnya, ajukan perubahan dan evaluasi kembali 2. Buat surat pemberitahuan ttg capaian iter dan share kembali aturan sesuai surat edaran ke DPJP 3. Humas mempromosikan layanan rehab dan informasikan kembali ke dr. eko	Karu irja Sekre, verif, irja Humas, rehab
7.	PPRA	1. form antibiotik belum diisi secara maksimal oleh seluruh unit, 2. penggunaan antibiotik golongan meropenem masih tinggi 3. keterlambatan pengisian oleh unit akan menghambat pemenuhan oleh farmasi 4. Profilaksis harap diberikan sesuai kebijakan yaitu kurang dari 6 menit sbm operasi 5. golongan (gentamicin dan lainnya) wajib diisi di form juga	1. Buat surat edaran untuk apa saja yg diisi di form 2. Sosialisasikan penggunaan antibiotik 3. All karu pastikan pengisian data tepat waktu tidak di tandon 4. Monev penggunaan profilaksis 5. Sosialisasikan dan Monev pengisian	Farmasi, sekre Farmasi All karu Farmasi farmasi

8.	KFT	1. Edukasi DPJP untuk pengajuan obat diluar formularium minta form ke sekre kft dan dengan persetujuan satu smf 2. Pelaporan miso belum berjalan maksimal 3. Evaluasi penmbahan atau pengurangan obat	1. Segera lakukan edukasi dan buat edaran jika belum ada untuk media edukasi 2. Ketika ada pasien ada alergi obat perawat irna segera laporkan ke apoteker irna 3. Ketika ada dokter evaluasi obat perlu pengurangan atau penambahan sampaikan ke kft	Farmasi All perawat All staf
9.	SDM	File kepegawaian staf akan disentralisasi di link, setiap unit setor email resmi unit untuk penambahan akses	segera setorkan email unit	All unit
10.	Radiologi	1. Kerusakan ct-scan yng berulang sehingga diperlukan SPO terbaru, bahwa setiap tindakan dilakukan jeda 1. Diagnose pasien pada permintaan ke radiologi tidak sesuai	1. all unit edukasi pasien 2. Penulisan diagnose dirincikan kembali detail	Radiologi All unit terkait
11.	IGD	Pemberian surat keterangan ijin, ada kendala dan sudah disampaikan programmer (kendala px umum tidak bisa diterbitkan secara langsung surat istrhtnya)	follow up ke programmer untuk kendala yang ada	IGD
12.	SKP	1. SKP 6 : penandaan resiko jatuh di unit belum terpenuhi sepenuhnya 2. gelang identitas yang rusak	1. Dilakukan pendataan ulang untuk pengajuan penandaan resiko jatuh di bed dan kursi roda, untuk yg rusak dll juga dilaporkan dan dilebih untuk stok 2. Adanya kerusakan gelang identitas mohon diperhatikan, stiker etiket di cek kembali	SKP All perawat

		3. pasien KRS masih menggunakan gelang identitas	3. Lakukan movev untuk pasien krs gelang identitas wajib sudah terlepas	All perawat, security
13.	Gizi dan Dapur	pada pemorsian ada banyak jamur di plafon, dan penyelesaian keramik belum selesai	gizi koordinasi dengan bagian umum untuk jadwal pengerjaan renovasi dapur	Gizi, kab umum
14.	Security	jam berkunjung blm berjalan maksimal	temen-temen di unit ikut serta melakukan movev jam berkunjung	All unit
15.	IRNA 3A	kamar vip tidak ada kunci, penunggu icu buka kamar untuk numpang kamar mandi	papan petunjuk arah toilet ditambah, edukasi oleh staf ke perawat untuk tempat2 umum di rs	ICU, security
16.	IRNA 2B	Folding usg echo belum rapih sehingga membutuhkan waktu lama saat mencari	Pengumpulan hasil usg echo dinamai nama pasien dan no.RM agar memudahkan saat mencari	Irna 2b dan all unit
17.	MATERNITAS	Doppler mater masih belum retur	Konfirm dan fu ke pengadaan pt untuk pengadaan doppler mater	Pengadaan pt, unit terkait
18.	CSSD	Pengiriman instrument belum berjalan maksimal	pengiriman instrumen wajib dijlankan sesuai jadwal yang sudah ditentukan, sosialisasikan dna remind all staf di grup koordinasi	Cssd, all unit
19.	HD	1. syring pump rusak (2) belum Kembali ke unit 2. pemenuhan k3 masih belum	1. follow up ke pengadaan 2. akan terpenuhi saat k3 baru ada	HD, pengadaan
20.	IRJA	pemenuhan b3 dan spilkit blm sepenuhnya	Ajukan dan penuhi kebutuhan	IRJA, PPI
21.	pendaftaran	1. APM sudah berjalan 2. pasien IGD dan rawat inap, masih pengurusan UHC, tidak ada SEP nya	1. lakukan movev dan laporkan secara berlaka terkait pelaksanannya 2. unit saling mengingatkan untuk pemenuhan sep pasien	Pdf, jangmed All unit
22.	Rekam Medik	1. PR SPO ERM belum dipenuhi	1. Segera penuhi dan ajukan ke kabit	Kabit jangmed, pdf

		2. retensi belum maksimal	2. update dan monev proses retensi, kasih target	jangmed
23.	Humas marketing	1. penjualan vaksin masih blm maksimal 2. maintenance iks di rumah sakit belum maksimal 3. promo paket mcu belum dijalankan	1. tingkatkan promosi untuk vaksin di rs 2. dijalankan tahun ini, siapkan target 3. jalankan seusai target	Humas, all staf
24.	Asuransi center	1. pasien dengan kll yg melanggar ketentuan dari kepolisian, bpjsnya tidak dapat digunakan. 2. pemberian oksigen untuk pasien IRNA dan IGD masih ada bberpa yg belum menginputkan	1. IGD mohon melengkapi kronologi secara detail apakah ada pelanggaran peraturan, sim ada atau tidak 2. penggunaan oksigen wajib diinputkan agar dapat muncul di rekam medis	Igd IRNA, IGD, all staf
25.	MOD	program mod (patient experience) : pengelolaan kesan pesan dengan tindak lanjut segera	Semua Staf wajib tau dan mendukung program	All staf

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari,S.Kep,M.Kep

Pasuruan, 21 April 2026

Notulis

Arindha Rahma Putri, S.Psi

DAFTAR HADIR

 **RSPHSKR**
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO, DESA LEMAHBANG KEC. SUKOREJO
KAB. PASURUAN
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Daftar Hadir RAPAT KOORDINASI APRIL 2026

Tempat : ANDALUSIA
Location

Tanggal dan : Selasa, 2026-04-21 13:00:00
Jam
Date Time

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Arindha Rahma Putri, S.Psi		administrasi	
2	dr Tamara Aulia Fakhrinnisa	Manajemen	Casemix	
3	Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep	RSPHSKR	Direktur RSPH Sukorejo	
4	wahyu rahmatun nisa	Umum	Humas & Marketing	
5	wahyu rahmatun nisa	Umum	Humas & Marketing	
6	Wahyu Rahmatun Nisa	RS Prima Husada Sukorejo	Humas dan marketing	
7	Wahyu Rahmatun Nisa	RS Prima Husada Sukorejo	Humas dan marketing	
8	Nur Lailatul Farida, S.Kep.,Ns	RSPH Sukorejo	Kabid Jang Med	
9	Wulandari	RS PRIMA HUSADA SUKOREJO	Kabid Umum	
10	Ilham Eka Novianto Putro, A.Md.Kep	RSPHSKR	Kepala Instalasi CSSD & Laundry RSPH Sukorejo	
11	Laili Choirul Umma, S.Farm.Apt.	RSPHSKR	Kepala Instalasi Farmasi RSPH Sukorejo	
12	Laili Choirul Umma, S.Farm.Apt.	RSPHSKR	Kepala Instalasi Farmasi RSPH Sukorejo	
13	Saila Nur Siti Khodijah, S.Gz	RSPHSKR	Kepala Instalasi Gizi & Dapur RSPH Sukorejo	
14	Galih Satria Mahardika, S.Pd	RSPHSKR	Kepala IT & SIMRS	
15	Debi Firmanasia, Amd.Kep	RSPHSKR	Kepala Ruang ICU RSPH Sukorejo	

DEPUKTO

Daftar Hadir
RAPAT KOORDINASI APRIL 2026

Tempat : ANDALUSIA
Location

Tanggal dan : Selasa, 2026-04-21 13:00:00
Jam
Date Time

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN
16	Bagas Surya Purwono, A.Md.Kep	IRJA	Kepala Ruang IRJA RSPH Sukorejo	
17	Siti Maysaroh, Amd.Kep	RSPHSKR	Kepala Ruang IRNA 3A RSPH Sukorejo	
18	Elza safarina ulfa	RSPHSKR	Kepala Ruang Laboratorium RSPH Sukorejo	
19	Elza safarina ulfa	RSPHSKR	Kepala Ruang Laboratorium RSPH Sukorejo	
20	Ninis indrawati	RSPHSKR	Kepala Ruang Maternitas RSPH Sukorejo	
21	Ahmad Yasin, S.Pd	RS Prima Husada Sukorejo	Pendaftaran	Ahmad Yasin
22	Allamul Angga Gilang Nishvu Ramadhan S.Kep.,Ns	HD	Perawat	
23	Nila Martiya Sani, Amd.Kep	IRNA 3A	Perawat	
24	Sinta Olivia Rahayu, S.Kep.Ns	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat	
25	Aini Nur Rokhma, A.Md.Kep	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat	
26	Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep.Ns	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat	
27	Nurul Kamilia, S.Tr.Kes	RS Prima Husada Sukorejo	Perekam Medis	
28	Nurul Kamilia, S.Tr.Kes	RS Prima Husada Sukorejo	Perekam Medis	
29	Erwan saputra	Satpam	PESERTA	
30	Kepala Unit SDM dan Diklat RSPH Sukorejo	RS Prima Husada Sukorejo	PESERTA	



RSPHSKR
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO, DESA LEMAHBANG KEC. SUKOREJO
KAB. PASURUAN
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Daftar Hadir
RAPAT KOORDINASI APRIL 2026

Tempat : ANDALUSIA
Location

Tanggal dan : Selasa, 2026-04-21 13:00:00
Jam
Date Time

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN
31	Kepala Unit SDM dan Diklat RSPH Sukorejo	RS Prima Husada Sukorejo	PESERTA	
32	Adinda riza febrianti, A.Md., Kes	Radiologi	PESERTA	
33	nuri aini izzah	mod	PESERTA	

DOKUMENTASI

